DEFINICIÓN

¿Cuáles son las tres formas de inestabilidad de la cadera en la DDC?

DEFINICIÓN

¿Qué es la displasia teratológica de cadera?

DEFINICIÓN

Malformación del pie que se asocia a DDC

EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia de la DDC

EPIDEMIOLOGÍA

¿Qué cadera se afecta con más frecuencia?

EPIDEMIOLOGÍA

Combinación clásica de factores de riesgo

EPIDEMIOLOGÍA

¿Qué práctica de crianza aumenta el riesgo de DDC?

TAMIZAJE

¿Cuándo se hace la primera exploración de caderas?

RESPUESTA · DEFINICIÓN

Luxación presente desde el útero, rígida e irreductible, asociada a enfermedades neuromusculares o síndromes.

RESPUESTA · DEFINICIÓN

Cadera luxada, luxable y subluxable.

RESPUESTA · EPIDEMIOLOGÍA

2 a 5 por cada 1,000 nacidos vivos.

RESPUESTA · DEFINICIÓN

Pie equino varo (también se asocia la tortícolis congénita).

RESPUESTA · EPIDEMIOLOGÍA

Niña, primer embarazo y presentación pélvica (más antecedente familiar).

RESPUESTA · EPIDEMIOLOGÍA

La izquierda; después la afección bilateral y por último la derecha.

RESPUESTA · TAMIZAJE

En la primera semana de vida.

RESPUESTA · EPIDEMIOLOGÍA

Envolver al bebé con las piernas juntas y en extensión.

TAMIZAJE

Calendario de exploración de caderas después del nacimiento

CLÍNICA

¿Qué maniobra luxa una cadera inestable?

CLÍNICA

¿Qué maniobra reduce una cadera luxada?

CLÍNICA

¿Hasta qué edad son útiles Barlow y Ortolani?

CLÍNICA

¿Qué significa un "click" de cadera en el recién nacido?

CLÍNICA

Signo más útil de DDC después de los 3 meses

CLÍNICA

¿Qué es el signo de Galeazzi?

CLÍNICA

Marcha típica del niño con luxación unilateral

RESPUESTA · CLÍNICA

Barlow: aducción con presión posterior. BarlOUT.

RESPUESTA · TAMIZAJE

Al mes y a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses.

RESPUESTA · CLÍNICA

Hasta los 3 meses; después pueden dar falsos negativos.

RESPUESTA · CLÍNICA

Ortolani: abducción con presión sobre el trocánter mayor. OrtolaIN.

RESPUESTA · CLÍNICA

Limitación de la abducción de la cadera.

RESPUESTA · CLÍNICA

Suele ser inocente y no indica displasia; lo patológico es el "clunk" de luxación o reducción.

RESPUESTA · CLÍNICA

Marcha de Trendelenburg (o de Duchenne).

RESPUESTA · CLÍNICA

Con caderas y rodillas flexionadas, una rodilla queda más baja por acortamiento del fémur del lado luxado.

IMAGEN

Estudio de imagen antes de los 4 meses

IMAGEN

¿El ultrasonido es tamizaje para todos los recién nacidos?

IMAGEN

Línea de Hilgenreiner

IMAGEN

Valor normal del índice acetabular al nacer

IMAGEN

Tríada de Putti

TRATAMIENTO

Tratamiento de primera elección en menores de 6 meses

TRATAMIENTO

Complicación más grave del arnés de Pavlik

TRATAMIENTO

Tratamiento entre los 6 y 18 meses

RESPUESTA · IMAGEN

No. Se indica ante exploración anormal o factores de riesgo.

RESPUESTA · IMAGEN

Ultrasonido de cadera, porque la cabeza femoral no está osificada.

RESPUESTA · IMAGEN

Menos de 30°.

RESPUESTA · IMAGEN

Línea horizontal que pasa por ambos cartílagos trirradiados.

RESPUESTA · TRATAMIENTO

Arnés de Pavlik.

RESPUESTA · IMAGEN

Cabeza femoral ascendida y lateralizada, núcleo de osificación pequeño y acetábulo displásico.

RESPUESTA · TRATAMIENTO

Reducción cerrada con tenotomía de aductores, artrografía y yeso pelvipodálico.

RESPUESTA · TRATAMIENTO

Necrosis avascular de la cabeza femoral.

TRATAMIENTO

Tratamiento en mayores de 18 meses

RESPUESTA · TRATAMIENTO

Reducción abierta (± osteotomías en niños mayores).